

26-2

허리 통증

Low back pain

질환 이해 › 채점 역산 › 실전 실행 › 인출

감별 대축

신경학적 침범이 있는가. 허리에서 끝나는가, 다리로 내려가는가

관문 1 · 응급

요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각 마비 › 마미증후군. 응급 수술로 감압해요

관문 2 · 기타

암 병력 · 체중감소 · 야간통 › 종양 / 발열 › 감염 / 복부 · 옆구리 증상 › 연관통

가장 흔한 정답

요추염좌. 무거운 걸 들거나 삐끗한 병력이 있으면 여기부터 봐요

시간 예산

Hx 5분 / PEx 4~5분 / Edu 2~3분. 서서 · 앉아서 · 누워서 세 자세를 다 써요

이 CC의 함정

SLR과 Patrick을 반드시 양측 모두 시행해야 각각 추간판탈출과 강직척추염이 갈려요

허리 통증은 목 통증과 문진 뼈대를 공유해요. 대축도 같고요. 그런데 질환 목록과 red flag가 전혀 달라요. 목에서는 수막염이 응급이었다면, 허리에서는 마미증후군이예요. 그리고 허리에는 목에 없는 층이 하나 더 있어요. 연관통 – 복부 · 신장 · 소화기 · 비뇨생식 질환이 허리 통증으로 옵니다.

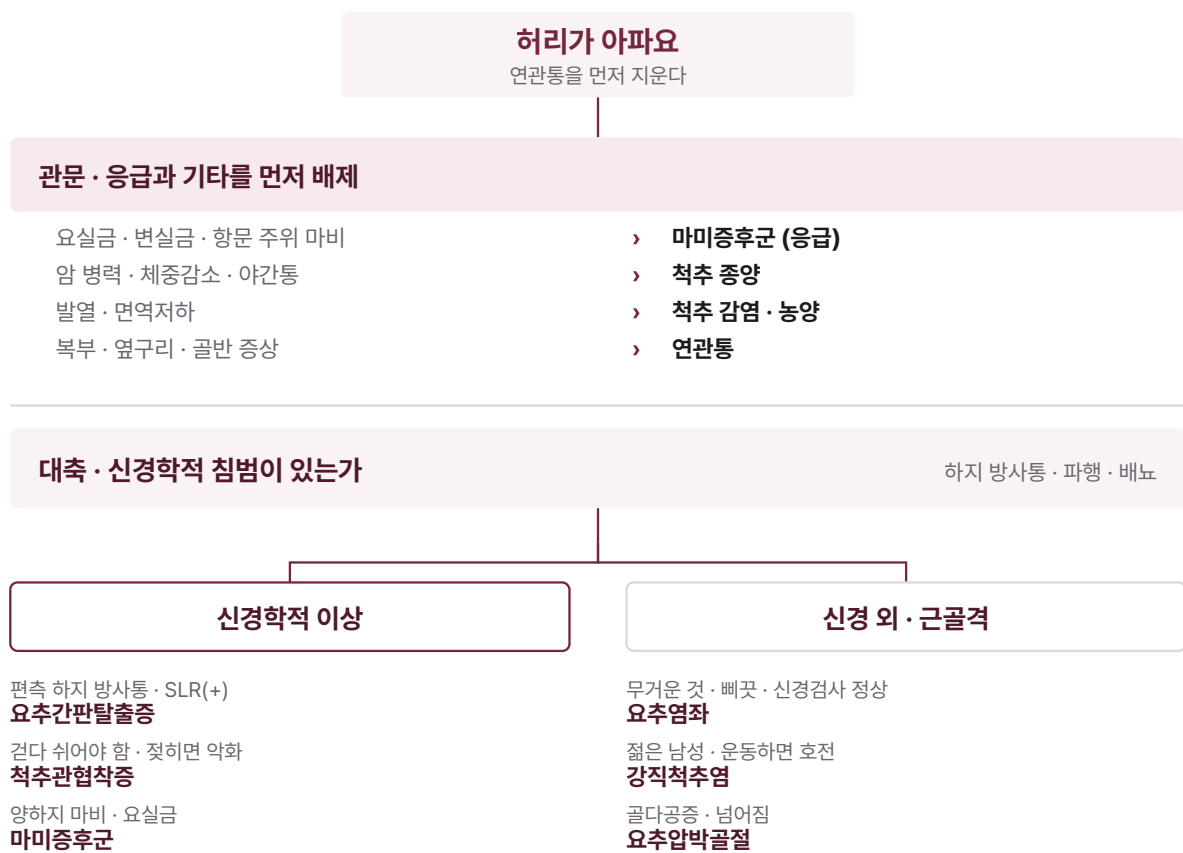
PART 0

이 CC에서 만나는 질환 지도

허리 통증도 세 덩어리예요. 신경학적 이상, 신경 외 근골격, 그리고 기타. 다만 기타 안이 목보다 훨씬 넓어요.

목에서 기타는 감염·종양·류마티스 셋이었어요. 허리에서는 여기에 **연관통**이 통째로 하나 더 붙어요. 배가 아파서 허리가 아플 수 있다는 뜻이에요. 복부대동맥류, 신우신염, 결석, 췌장염, 담낭염, 자궁내막증, 전립선염이 전부 허리 통증으로 올 수 있어요.

그래서 관문이 두 층이에요. **첫째 층은 마미증후군**이에요. 요실금과 변실금이 나오면 다른 걸 다 제쳐두고 응급 수술로 갑니다. **둘째 층은 종양·감염·연관통**이고요.



응급을 먼저 지우고, 기타를 지우고, 그 다음 신경 침범 여부로 좌우가 갈린다

0-1. 질환들의 첫인상

덩어리	질환	환자가 보이는 모습
신경학적	요추간판탈출증	허리가 아픈데 한쪽 다리로 내려가고 저려요. 기침하면 확 심해지고요
신경학적	척추관협착증	조금 걸으면 다리가 아파서 쉬어야 해요. 허리를 젖히면 심하고 앉으면 편해요
	마미증후군	소변과 대변이 새요. 양쪽 다리에 힘이 없고 엉덩이 쪽 감각이 둔해요

덩어리	질환	환자가 보이는 모습
신경학적 · 응급		
신경학적 · 종양	척추 종양	예전에 암 진단을 받았어요. 체중이 빠지고 밤에 더 아파요
근골격	요추염좌	무거운 걸 들다가 삐끗했어요. 허리 근육이 아프고 다리로는 안 내려가요
근골격	요추압박골절	골다공증이 있는데 살짝 넘어진 뒤부터 허리가 아파요. 굽히기가 어렵고요
류마티스	강직척추염	20대 남자인데 아침에 허리가 뻣뻣해요. 움직이면 오히려 나아지고 쉬면 더 아파요
류마티스	골관절염	50세 이상이고 조조강직이 30분 미만이에요. 움직일 때 서걱거려요
기타 · 연관통	복부대동맥류	고령에 박동성 덩어리가 만져지고 허리가 아파요
기타 · 연관통	신우신염 · 결석	옆구리를 두드리면 아프고 열이 나거나 소변에 피가 섞여요
기타 · 연관통	혜장염 · 담낭염	배가 아픈데 등으로 뻗쳐요. 식사와 관계가 있고요
기타 · 연관통	자궁내막증 · PID · 전립선염	월경과 관계있게 아프거나, 골반 · 배뇨 증상이 같이 와요

스스로 답해 보기

Q 허리 통증에만 있고 목 통증에는 없는 감별 총 하나는 무엇인가?

Q 다른 걸 다 제쳐두고 먼저 확인해야 하는 응급은 무엇이고, 그 질문 두 개는?

PART 1

대축은 목과 같고, 관문은 다릅니다

허리에서 끝나는가, 다리로 내려가는가. 대축은 목과 똑같아요. 다른 건 그 앞에 놓인 관문이에요.

1-1. 대축 - 신경학적 침범

판정 도구는 네 가지예요. 다리로 내려가는 **방사통(sciatica)**, **파행(claudication)**, **다리 힘 빠짐(weakness)**, **배뇨·배변 이상**. 이 중 하나라도 있으면 신경학적 이상 칸이에요.

왜 이게 대축일까요? 목과 같은 이유예요. 질문 두세 개로 판정되고, 진찰로 확인되고, **치료 방향이 통째로 갈려요**. 신경 침범이 없으면 보존적 치료로 끝나고, 있으면 영상과 수술 논의로 넘어갑니다.

1-2. 관문 1 - 마미증후군을 먼저 지워요

척수는 요추 위쪽에서 끝나고, 그 아래로는 신경뿌리들이 말 꼬리처럼 다발로 내려가요. 이것 **cauda equina**, **마미**라고 해요. 이 다발이 한꺼번에 눌리면 방광·직장·회음부를 담당하는 뿌리들이 동시에 나빠집니다.

그래서 증상 조합이 특이해요. **요실금·변실금 + 양쪽 다리 근력 저하 + 항문 주위와 회음부 감각 마비**. 한쪽이 아니라 양쪽이고, 감각이 없어지는 자리가 안장에 닿는 부위예요.

이건 응급 수술로 완전히 감압해야 하는 상황이에요. 늦으면 배뇨 기능이 돌아오지 않습니다. 쉽게 말하면 **전선 다발이 통째로 눌린** 셈이라 시간이 곧 기능이에요.

1-3. 관문 2 - 종양·감염·연관통

암 병력·체중 감소·야간 통증 척추 종양. 밤에 더 아프다는 말이 결정적이에요. **관문**

발열·면역저하·최근 시술 척추 감염·경막외 농양. **관문**

박동성 복부 덩어리·고령·흡연 복부대동맥류. **관문**

옆구리 통증·혈뇨·발열 신우신염·요로결석. **관문**

식사와 관련된 복통·등으로 방사 췌장염·담낭염·담석증. **관문**

월경 관련·골반·배뇨 증상 자궁내막증·PID·전립선염. **관문**

연관통을 놓치면 위험한 이유는 단순해요. **허리를 아무리 진찰해도 답이 안 나오고, 그 사이에 진짜 병이 진행하기 때문**이에요. 그래서 문진에서 복부·옆구리·배뇨 증상을 한 번은 훑어야 해요.

1-4. 실제로 헛갈리는 두 쌍

신경성 파행 vs 혈관성 파행

둘 다 걷다가 다리가 아파서 쉬다고 말해요. 그런데 원인이 완전히 달라요.

	신경성 (척추관협착증)	혈관성 (말초동맥질환)
자세	허리를 젖히면 악화, 굽히면 완화	자세와 무관
쉬는 방법	앉거나 허리를 굽혀야 편해요	서서 쉬어도 좋아져요
자전거	허리를 굽히니까 잘 타요	다리를 쓰니까 똑같이 아파요
맥박	정상	말초동맥 맥박이 약하거나 없음

그래서 척추관협착증이 의심되면 **말초동맥 맥박을 만져 혈관성 파행을 배제**해요. 진찰 항목에 이게 들어 있는 이유예요.

염증성 요통 vs 기계적 요통

염증성은 아침에 뻣뻣하고 **쉬면 더 아프고 움직이면 나아져요**. 강직척추염이죠. **기계적**은 움직이면 아프고 쉬면 나아져요. 요추염좌고요. 이 방향 하나가 두 질환군을 통째로 가릅니다.

여기에 나이와 성별을 얹으면 더 선명해져요. **20~30대 젊은 남자**가 아침에 허리가 뻣뻣하고 운동하면 나아진다고 하면 강직척추염을 먼저 떠올려요.

스스로 답해보기

- Q 마미증후군의 세 가지 소견은? 왜 양쪽에 오는가?
- Q 신경성 파행과 혈관성 파행을 가르는 질문 두 개는?

PART 2

최소 기초 세 덩어리

2-1. 척수는 요추 위에서 끝나고, 아래는 신경 다발이에요

척수는 대개 첫째 또는 둘째 요추 높이에서 끝나요. 그 아래 척추관 안에는 척수가 없고 **신경뿌리들이 말 꼬리처럼 다발로** 내려가죠. 이 구조 차이가 목과 허리의 증상을 가릅니다.

목에서는 척수가 눌리면 그 아래 전부가 나빠졌어요. 허리에서는 척수가 없으니 그런 일이 안 생겨요. 대신 **다발이 한꺼번에 눌리는** 상황이 생기는데, 그게 마미증후군이에요. 한 뿌리만 눌리면 한쪽 다리, 다발이 눌리면 양쪽 다리와 방광·직장이에요.

› 이 개념은 1-2 마미증후군, 3-4 마미증후군 루프, PART 6의 A 마미증후군 질문에서 회수돼요.

2-2. 하지 피부분절과 근절 - 어느 뿌리인지는 발이 알려줘요

허리에서 문제가 되는 뿌리는 주로 셋이에요. **L4 · L5 · S1**. 각각 담당하는 감각 구역과 근육, 반사가 정해져 있어서 환자가 어디가 저린지만 말해도 높이가 잡혀요.

뿌리	감각 · 저린 곳	근력	반사
L4	정강이 안쪽	발목 젖히기	무릎 반사
L5	엄지발가락 · 발등	엄지 젖히기	-
S1	새끼발가락 · 발바닥	발끝으로 서기	발목 반사

환자가 저리다고 말한 손가락 하나가 병소의 높이를 지목한다.

하지 피부분절 · 근절 · 반사. 저린 발가락 하나가 높이를 알려준다

실전에서 특히 유용한 게 **발끝으로 서기**와 **발뒤꿈치로 걷기**예요. 발끝으로 못 서면 S1, 발목을 못 젖히면 L4~L5 쪽이에요. 근력을 숫자로 재는 것보다 이 동작 두 개가 빠르고 정확해요.

› 이 개념은 3-2 요추간판탈출증, PART 6의 A 추간판탈출증 질문, PART 7의 하지 감각 · 근력 · DTR에서 회수돼요.

2-3. 허리를 젖히면 통로가 좁아지고, 굽히면 넓어져요

척추관과 추간공은 **허리를 젖히면 좁아지고 굽히면 넓어져요**. 젖히면 뒤쪽 구조물이 겹치면서 공간을 먹고, 굽히면 그 겹침이 풀리거든요.

이 사실 하나가 척추관협착증의 증상 전부를 설명해요. 서서 걸으면 자연히 허리가 약간 젖혀지니까 통로가 좁아져 다리가 아프고, 앉거나 허리를 굽히면 넓어져서 편해져요. 쉽게 말하면 **좁은 문이 자세에 따라 열렸다 닫혔다** 하는 셈이에요.

그래서 환자가 **쇼핑 카트를 밀면 오래 걷는다거나 자전거는 잘 탄다**고 말해요. 둘 다 허리를 굽힌 자세거든요. 이 진술이 나오면 협착증이 거의 확정돼요.

› 이 개념은 3-3 척추관협착증, 1-4의 파행 감별, PART 6의 F 자세 항목, PART 7의 허리 extension 제한에서 회수돼요.

스스로 답해보기

- Q 목과 허리에서 척수 구조가 어떻게 다른가? 그게 증상을 어떻게 바꾸는가?
 - Q 발끝으로 못 서면 어느 뿌리인가?
 - Q 척추관협착증 환자가 자전거를 잘 타는 이유는?
-

PART 3

핵심 질환 한 바퀴

다섯만 정상에서 고장까지 돌려요. 가장 흔한 것 하나, 신경 침범 둘, 응급 하나, 염증성 하나.

3-1. 요추염좌

가장 흔한 원인. 왜 2주면 괜찮아질까요?

환자

어제 무거운 짐을 들다가 허리를 삐끗했어요.
허리 근육이 뻣근하게 아픈데 다리로 내려가진 않아요.
구부리기가 힘들고 움직이면 더 아파요.

결정적인 건 **사건 + 다리로 안 내려감 + 움직이면 악화**예요. 허리 통증에서 가장 흔한 원인이고, 이 셋이 모이면 신경학적 이상 칸이 통째로 지워져요.

왜 근육과 인대가 다칠까요?

무거운 것을 들 때 허리는 지렛대의 받침점이 돼요. 물건이 몸에서 멀수록 허리에 걸리는 힘이 몇 배로 커지죠. 준비 없이 갑자기 힘이 걸리면 근섬유와 인대에 미세 손상이 생기고, 염증 매개물질이 나와 통증과 근경직을 만들어요.

왜 신경학적 검사가 정상일까요?

병소가 근육과 인대이지 신경뿌리가 아니거든요. 그래서 **SLR도 음성이고 근력·감각·반사가 다 정상**이에요. 대신 압통점이 있고 허리 운동이 제한돼요. 이 조합이 요추염좌의 진찰 소견이에요.

왜 2주면 괜찮아진다고 말할까요?

근육과 인대의 미세 손상은 스스로 아무는 조직이에요. 급성 염증이 가라앉고 조직이 재생되는 데 보통 그 정도가 걸려요. 그래서 **안심시키는 것 자체가 치료의 일부**예요. 다만 무리한 활동은 제한하고 진통제와 온찜질로 통증을 줄여 줘요.

쌍둥이 감별 - 요추간판탈출증. 둘 다 무거운 걸 들다가 시작될 수 있어요. 갈라주는 건 **다리로 내려가나요, 저리나요** 한 문장이예요. 염좌는 방사통이 없어요.

CPX 연결. O에서 무거운 짐·삐끗 사건을 잡고 > L에서 다리로 안 내려감을 확인하고 > F에서 움직이면 악화를 받아내고 > A 척추 염좌에서 굽히기 어려운지 묻고 > PEx에서 압통점·허리 ROM·정상 신경학적 검사 > Edu에서 2주면 좋아진다고 안심시키고 자세 교정과 온찜질을 설명해요.

SP 언어 사인 무거운 걸 들다가 삐끗했어요·허리가 뻣근해요·다리로 안 내려가요·구부리기가 힘들어요

3-2. 요추간판탈출증

왜 한쪽 다리로 내려가고, 왜 기침하면 심해질까요?

환자

허리가 아픈데 오른쪽 엉덩이에서 종아리까지 내려가요.
발가락 쪽이 저릿저릿합니다.
기침하거나 힘을 주면 확 심해져요.

결정적인 건 **편측 하지 방사통 + 저림 + 복압 상승에서 악화**예요. 한쪽이라는 게 중요해요. 양쪽이면 마미증후군이나 협착증 쪽으로 가야 하거든요.

왜 한쪽일까요?

추간판이 뒤쪽 옆으로 튀어나오는 일이 많아요. 뒤 정중앙은 두꺼운 인대가 막고 있어서 상대적으로 옆이 약하거든요. 옆으로 나가면 그쪽 신경뿌리 하나만 눌리니까 **한쪽 다리에만** 증상이 생겨요.

왜 기침하면 심해질까요?

기침이나 배변 시 힘을 주면 배 안의 압력이 올라가고, 그 압력이 척추관 안의 정맥총으로 전달되어 **신경뿌리 주변이 순간적으로 부풀어**요. 이미 눌려 있는 신경이 더 눌리니 통증이 확 커지죠. 쉽게 말하면 **꽉 찬 방에 사람이 더 들어오는** 셈 이에요.

왜 SLR이 양성일까요?

무릎을 편 채 다리를 들면 좌골신경이 위로 당겨져요. 정상이면 여유가 있어 안 아픈데, 신경뿌리가 눌려 있으면 조금만 당겨도 이미 눌린 부위가 자극되어 **원래의 방사통이 재현**돼요. 허벅지 뒤가 빠근하게 당기는 건 근육이 늘어난 것이라 양성이 아니에요.

왜 대부분 수술을 먼저 안 할까요?

튀어나온 수핵은 시간이 지나면 수분이 빠지고 흡수되어 줄어들 수 있어요. 그래서 침상 안정 · 물리 치료 · NSAID로 시간을 벌어요. 다만 예외가 있어요. **다리 힘이 급격히 약해지거나 대소변 장애가 생기면 응급**으로 넘어갑니다.

쌍둥이 감별 - 척추관협착증. 둘 다 다리로 내려가요. 갈라주는 건 **한쪽인가 양쪽인가와 걷다가 쉬어야 하나**예요. 협착증은 양쪽이고 파행이 있어요.

CPX 연결. L에서 편측 방사 경로를 그리게 하고 > A 추간판탈출증에서 다리 근력과 감각 저하를 묻고 > F에서 기침 · 힘줄 때 악화를 확인하고 > PEx에서 하지 감각 · 근력 · DTR과 **SLR** > 검사는 L-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 보존적 치료 우선과 응급 상황을 설명해요.

SP 언어 사인 엉덩이에서 종아리로 내려가요 · 발가락이 저려요 · 기침하면 확 심해져요 · 한쪽만 아파요

3-3. 척추관협착증

왜 걷다가 쉬어야 하고, 왜 앉으면 편해질까요?

환자

백 미터쯤 걸으면 다리가 저리고 아파서 쉬어야 해요.

앉아서 쉬면 금방 괜찮아지고 다시 걸을 수 있어요.

허리를 젖히면 더 아프고, 카트 밀고 장 볼 때는 오래 걸을 수 있어요.

결정적인 건 **파행 + 자세 의존성**이에요. 걷다가 쉬어야 한다는 것과 **앉거나 굽히면 편하다**는 것. 이 둘이 같이 나오면 협착증이 거의 확정돼요.

왜 척추관이 좁아질까요?

나이가 들면서 추간판이 납작해지고, 후관절이 두꺼워지고, 황색인대가 접혀 들어와요. 세 방향에서 조금씩 공간을 먹으니 통로가 좁아집니다. 그래서 **50세 이상에서 서서히** 나빠지는 경과를 보여요.

왜 걸으면 아플까요?

서서 걸으면 허리가 자연히 약간 젖혀지고, 젖히면 통로가 더 좁아져요. 게다가 운동하는 신경은 혈류가 더 필요한데 눌린 상태에서는 공급이 안 따라가요. 그래서 **걷는 동안에만 증상이 나오고 멈추면 회복**돼요.

왜 앉으면 좋아질까요?

앉거나 허리를 굽히면 통로가 넓어지거든요. 그래서 앉아서 쉬면 금방 편해지고, 카트를 밀거나 자전거를 탈 때처럼 굽힌 자세에서는 오래 버텨요. **이 자세 의존성이 혈관성 파행과 갈라주는 결정적 단서**예요.

왜 신경학적 검사가 대개 정상일까요?

가만히 있을 때는 압박이 심하지 않기 때문이에요. 진료실에서 누워서 검사하면 감각과 근력이 정상으로 나오는 경우가 많아요. 그래서 **증상은 심한데 진찰은 정상**이라는 불일치 자체가 이 진단을 시사해요. 다만 허리 extension은 제한돼요.

쌍둥이 감별 - 말초동맥질환. 둘 다 걷다가 쉬어요. 갈라주는 건 **앉아야 좋아지나요, 서서 쉬어도 좋아지나요**와 말초동맥 맥박이에요.

CPX 연결. A 척추관협착증에서 파행을 묻고 > F 자세에서 젖히면 악화 · 앉으면 완화를 확인하고 > PEx에서 허리 extension 제한과 **말초동맥 맥박 촉진** > 검사는 L-spine X-ray와 CT/MRI > Edu에서 보존적 치료와 자세 교육을 설명해요.

SP 언어 사인 조금 걸으면 다리가 아파서 쉬어요 · 앉으면 금방 나아요 · 젖히면 더 아파요 · 카트 밀면 오래 걸어요

3-4. 마미증후군

왜 이게 이 CC의 유일한 응급일까요?

환자

사흘 전부터 허리가 심하게 아프더니 어제부터 소변이 새요.

양쪽 다리에 힘이 없고 걷기가 힘듭니다.

엉덩이 쪽하고 사타구니 감각이 둔해요.

결정적인 건 **배뇨 · 배변 이상 + 양쪽 다리 + 안장 부위 감각 마비** 삼중 조합이에요. **한쪽이 아니라 양쪽**이라는 게 핵심이에요.

왜 양쪽에 올까요?

요추 아래 척추관에는 신경뿌리들이 다발로 내려가고 있어요. 큰 추간판 탈출이나 종양이 가운데를 누르면 **그 다발 전체가 한꺼번에 눌러요**. 좌우 뿌리가 함께 있으니 양쪽에 증상이 생기죠. 쉽게 말하면 전선 하나가 아니라 **전선 다발이 통째로 눌린** 셈이에요.

왜 소변과 대변이 먼저 티가 날까요?

방광과 직장을 조절하는 뿌리가 이 다발의 아래쪽에 모여 있어서예요. 그리고 배뇨 기능은 한번 손상되면 회복이 잘 안 돼요. 그래서 **이 증상이 나오면 시간이 곧 기능**이에요.

왜 안장 부위 감각이 마비될까요?

회음부와 항문 주변, 그러니까 **안장에 닿는 부위**를 담당하는 뿌리가 함께 눌리기 때문이에요. 그래서 이 부위 감각을 확인하는 게 진찰의 핵심이에요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않는 경우도 많고요.

왜 응급 수술일까요?

압박이 계속되면 신경이 비가역적으로 손상되기 때문이에요. 보존적 치료로 기다릴 수 있는 상황이 아니라 **응급 수술로 완전히 감압**해야 해요. 허리 통증 CC에서 이 진단만 다른 모든 것보다 우선합니다.

쌍둥이 감별 - 요추간판탈출증. 같은 추간판이 원인일 수 있어요. 갈라주는 건 **한쪽인가 양쪽인가**와 **소변·대변에 문제가 있나**예요.

CPX 연결. A 마미증후군에서 요실금·변실금·항문 주위 감각을 묻고, L에서 양쪽임을 확인하고, PEx에서 양하지 근력·심부건 반사 저하와 회음부 감각, 검사는 L-spine MRI, Edu에서 응급 수술이 필요한 이유를 설명해요.

SP 언어 사인 소변이 새요·양쪽 다리에 힘이 없어요·엉덩이 쪽 감각이 둔해요·걸기가 힘들어요

3-5. 강직척추염

왜 쉬면 더 아프고 움직이면 나아질까요?

환자

스물여덟 살 남자입니다. 반년 전부터 허리와 엉치가 아파요.
아침에 한 시간 넘게 뻣뻣하고, 움직이면 오히려 나아져요.
누워 있으면 더 아파서 새벽에 일어나 걸어 다닙니다.
얼마 전에 눈이 빨개지고 아파서 안과에 갔어요.

결정적인 건 **젊은 남자 + 조조강직 + 휴식에서 악화·운동에서 호전**이에요. 기계적 요통과 정확히 반대 방향이라, 이 한 가지로 요추염좌 계열이 통째로 내려가요.

왜 부착부에 염증이 생길까요?

강직척추염은 힘줄과 인대가 뼈에 붙는 자리, 그러니까 **부착부(entheses)**에 염증이 생기는 병이에요. 척추와 천장관 절은 인대 부착부가 밀집한 곳이라 여기가 먼저 걸려요. 그래서 허리와 엉치가 아프죠.

왜 쉬면 더 아플까요?

염증성 삼출액이 가만히 있는 동안 관절 주위에 고이기 때문이에요. 움직이면 그게 흩어져 통증이 줄고요. 그래서 **새벽에 아파서 일어나 걸어 다닌다**는 진술이 나와요. 기계적 요통 환자는 절대 이런 말을 하지 않아요.

왜 척추가 굳을까요?

염증이 반복되면 그 자리에 새 뼈가 자라 척추뼈끼리 다리를 놓아요. 시간이 지나면 마디가 붙어 **허리가 안 굽는 상태**가 됩니다. Schober test가 재는 게 정확히 이거예요. 굽혔을 때 피부가 늘어나는 거리가 줄어들거든요.

왜 눈과 장을 같이 물을까요?

같은 면역 축을 공유하는 질환군이라 관절 밖 침범이 흔해요. **포도막염**이 대표적이고, 궤양성 대장염 같은 **염증성 장질환**이 동반되기도 해요. 그래서 눈 충혈과 통증, 설사와 복통을 함께 묻고, 포도막염이 의심되면 **안과 검진**을 추가해요.

쌍둥이 감별 - 요추염좌. 둘 다 젊은 사람에게 와요. 갈라주는 건 **쉬면 나아지나**요, **움직이면 나아지나**와 조조강직 지속시간이에요.

CPX 연결. A 강직척추염에서 조조강직·포도막염·설사·복통을 묻고, F 운동에서 휴식 시 악화를 확인하고, PEx에서 **Schober test**와 Patrick test에서 반대측 통증, 필요하면 chest expansion, 검사는 Lumbar X-ray·HLA-B27·ESR·CRP, Edu에서 재활과 운동 치료, 안과 검진 예약을 설명해요.

SP 언어 사인 아침에 허리가 뻣뻣해요 · 움직이면 나아요 · 누워 있으면 더 아파요 · 눈이 빨개지고 아팠어요

3-6. 나머지는 결정 단서만

질환	덩어리	결정 단서	검사 · 치료
척추 종양	신경학적 · 종양	이전 암 병력, 체중 감소, 야간 통증 , 하지 감각 이상과 근력 감소	L-spine X-ray · CT/MRI / 방사선 · 항암 · 수술
요추압박골절	근골격 · 뼈	골다공증, 가볍게 넘어짐, 요통과 요추부 운동 제한	L-spine X-ray · CT/MRI / 요추보조기 · NSAID · Opioid · 골다공증 치료 · 수술
골관절염	류마티스 · 기타	50세 이상, 조조강직 30분 미만, 비침소리, ROM 감소	- / NSAID · 재활 및 운동 치료 · 생활 습관 개선
척추 감염 · 농양	기타 · 감염	발열, 면역저하, 최근 수술, 야간통이 동반되기도 해요	MRI · 염증수치 / 항생제 · 필요 시 배농
복부대동맥류	기타 · 연관통	고령, 박동성 복부 덩어리, 갑작스러운 허리 · 복부 통증	복부 초음파 · CT / 응급 수술 고려
신우신염 · 요로결석	기타 · 연관통	옆구리 통증, 늑골척추각 압통, 혈뇨나 발열	소변검사 · 영상 / 항생제 · 진통 · 배석 치료
췌장염 · 담낭염 · 담석증	기타 · 연관통	식사와 관련된 복통이 등으로 뻗쳐요	혈액 · 복부 영상 / 원인 질환 치료
자궁내막증 · PID · 전립선염	기타 · 연관통	월경 관련 통증, 골반 · 배뇨 증상 동반	부인과 · 비뇨의학과 평가 / 원인 질환 치료

3-7. 다섯 질환을 네 축으로

	방사	악화	완화	신경학적 검사
요추염좌	없음	움직이면	쉬면	정상
추간판탈출증	편측 하지	기침 · 힘줄 때	눕거나 안정	SLR(+), 근력 · 감각 · 반사 이상
척추관협착증	양측 하지	걷기 · 젖힘	앉기 · 굽힘	대개 정상, extension 제한
마미증후군	양측 하지	-	-	양하지 근력 · 반사 저하, 안장 감각 마비
강직척추염	엉치	휴식 · 아침	운동	Schober(+), Patrick 반대측 통증

스스로 답해보기

Q 요추간판탈출증이 왜 한쪽에만 오는가?

Q 기침할 때 심해지는 기전은?

Q 척추관협착증에서 증상은 심한데 진찰이 정상인 이유는?

Q 강직척추염이 쉬면 더 아픈 기전은?

PART 4

채점 역산표

허리는 진찰이 세 자세로 나뉘어 시간이 빠듯해요. 문진을 빨리 닫아야 해요.

4-1. MUST

A 마미증후군 요실금·변실금·항문 주위 감각 이상. 응급을 거르는 줄이에요. **MUST**

L 방사통 대축을 가르는 질문. 그리고 한쪽인지 양쪽인지. **MUST**

A 전신 발열·체중 변화. 감염과 암 전이를 지목해요. **MUST**

A 추간판탈출증 다리 근력 저하·감각 저하. **MUST**

A 척추관협착증 걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하는지(파행). **MUST**

A 강직척추염 조조강직·포도막염·설사·복통. **MUST**

F 자세·운동 젖힘인지 굽힘인지, 휴식인지 활동인지. **MUST**

외 외상·골절력 압박골절과 골다공증의 배경. **MUST**

과·골다공증 검사 여부 골절과 종양을 세워요. **MUST**

4-2. SHOULD와 DROP

등급	항목	왜 그 등급인가
SHOULD	A 정신·우울	만성 요통과 기분 증상은 서로를 악화시켜요
SHOULD	A 척추 염좌·굽히기 어려운지	근육·인대 손상을 시사해요
SHOULD	Ex 이전 치료와 반응	치료 반응이 진단 정보가 돼요
SHOULD	사 직업·근무 자세·운동	요추 부하의 배경이자 교육에서 교정할 대상
SHOULD	가 류마티스·척추·신경계 가족력	강직척추염은 가족 집적성이 뚜렷해요
DROP	E 건강검진	골밀도 언급이 나오면 유용하지만 대개 정보가 없어요
DROP	Co 점점 심해지나요	O·D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠지면 종양을 올려요
DROP	C 압통·발적·종창·열감	관절 CC의 항목이라 허리에서는 기여가 낮아요
DROP	여 폐경	골다공증 배경으로만 의미가 있어요

버리는 순서는 C 염증 소견 > E > 여 > Co예요. **MUST** 아홉 개, 특히 마미증후군 줄은 어떤 경우에도 지켜요.

PART 5

문진 개관

목과 뼈대는 같아요. 다른 건 A의 구성과, 그 안에 응급이 들어 있다는 점이에요.

앞쪽 절반(O · L · D · Co · Ex · C)이 통증을 해부하고, **L의 방사통 하나가 대축을 결정**해요. 여기까지는 목과 똑같아요.

A가 달라요. 일곱 줄 중 **마미증후군 줄이 응급**이고, 나머지가 각각 추간판탈출증 · 척추관협착증 · 강직척추염 · 척추염좌를 겨냥해요. 그리고 **전신 줄이 감염과 암 전이 둘을 동시에** 훑고요.

F는 허리에서 특히 무거워요. **자세**가 협착증(젖힘 악화 · 굽힘 완화)과 추간판탈출증(기침 · 힘줄 때 악화)을 갈라주고, **운동**이 강직척추염(휴식 악화)과 요추염좌(활동 악화)를 갈라주거든요. 질문 두 개가 네 질환을 정리해요.

문진의 뼈대 한 줄 - 마미증후군을 먼저 지우고, 방사통으로 대축을 정하고, 자세와 운동 방향으로 네 질환을 가른다.

5-1. 암기법

항목	암기법	풀이
A 동반	허리 아파 탈출하는 협객은 맘이 강직하다	탈출 - 추간판탈출증(다리 근력 · 감각) · 협 - 척추관협착증(파행) · 맘 - 마미증후군(요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각) · 강직 - 강직척추염(조조강직 · 포도막염 · 설사 · 복통)

여기에 맨 앞의 **전신**(발열 · 오한 · 피로 · 체중 변화)과 뒤의 **정신**(우울), **척추 염좌**(굽히기 어려운지)를 더하면 일곱 줄이 완성돼요.

PART 6

History taking

6-1. O – 사건을 특정해요

허리 통증의 O에도 사건 질문이 있어요. 기침 · 넘어짐 · 허리 삐끗 · 걷다가가 대표적이고, 각각 다른 질환을 지목해요.

O 발생 MUST

언제부터 허리가 아팠나요? 갑자기인가요, 서서히인가요? 특별히 어떤 상황에서 시작되었나요?

사건이 잡히면 질환군이 통째로 올라와요. 기침 · 넘어짐 · 삐끗 · 걷다가 넷을 제시하면 환자가 잘 답해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
무거운 것을 들다 삐끗	요추염좌 · 추간판탈출증	준비 없이 큰 힘이 걸리면 근육 · 인대와 추간판이 함께 손상된다
기침하다가	요추간판탈출증 · 압박골절	복압 상승이 추간판과 약해진 척추체에 순간적 부하를 준다
가볍게 넘어진 뒤	요추압박골절	낮은 에너지 손상에서 골절되면 골강도가 낮다는 뜻이다
걷다가	척추관협착증	보행 자세에서 통로가 좁아져 증상이 나온다
서서히 몇 달	협착증 · 강직척추염 · 종양	구조 변화나 염증이 누적되어야 증상이 나온다

6-2. L – 대축을 가르고, 한쪽인지 양쪽인지까지

목과 같은 항목인데 하나가 더 붙어요. **한쪽인가 양쪽인가**. 편측이면 추간판탈출증, 양측이면 협착증이나 마미증후군으로 갈려요.

I 부위 · 방사 MUST

통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요? 통증이 어디로 뻗어나요? 한쪽인가요, 양쪽인가요? 허리 외에 아픈 곳은 없나요?

대축을 가르고 편측 · 양측까지 확정해요. 허리 외 부위를 묻는 건 연관통을 지우기 위해서예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
한쪽 엉덩이에서 다리로	요추간판탈출증	추간판이 뒤쪽 옆으로 나가 그쪽 뿌리 하나만 누른다
양쪽 다리로	척추관협착증 · 마미증후군	가운데 통로가 좁아지면 좌우 뿌리가 함께 눌린다
허리에만 국한	요추염좌 · 압박골절	병소가 근육 · 인대 · 뼈라 신경 경로를 따라갈 이유가 없다
허리와 엉치	강직척추염	천장관절과 척추 부착부가 표적이다
옆구리로	신우신염 · 요로결석	신장에서 오는 연관통이다
배가 아픈데 등으로	췌장염 · 담낭염 · 대동맥류	복부 장기의 통증이 등으로 전달된다

6-3. D · Co · Ex

D 지속 · 빈도 SHOULD

통증이 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?

지속과 빈도가 급성 사건인지 만성 진행인지를 갈라요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
걸을 때만 잠깐	척추관협착증	보행 자세에서만 통로가 좁아진다
하루 종일	염증성 · 종양	자극과 무관하게 아프면 조직 자체의 병변이다
밤에 심해진다	척추 종양 · 감염	야간통은 red flag로 다뤄야 한다
며칠째 점점	급성 사건 후 경과	손상 후 염증 반응이 자리를 잡는 시간이다

Co 진행 DROP

통증이 점점 더 심해지나요?

O·D와 겹쳐요. 다만 계속 나빠진다는 답은 종양과 감염을 위로 올려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
계속 나빠진다	종양·감염	병변이 커지거나 진행하고 있다
좋아졌다 나빠졌다	염좌·협착증	자세와 활동량에 따라 오르내린다
2주쯤 지나 좋아지고 있다	요추염좌	근육과 인대의 미세 손상은 스스로 아문다

Ex 과거 삽화·치료 반응 SHOULD

이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요? 진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?

치료 반응이 진단 정보가 돼요. 반복 여부는 만성 구조 문제를 시사하고요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
전에도 같은 통증	만성·재발성	구조적 원인이나 자세 습관이 남아 있다
진통제에 반응	염증성·근골격	약물 반응성이 간접 근거가 된다
약을 먹어도 그대로	신경병증·종양·감염	일반 진통제로 조절되지 않으면 기전이 다르다
처음이다	급성 사건	새로 생긴 원인을 찾는다

6-4. C – 양상과 강도

C 양상·강도 MUST

통증이 어떤 양상인가요? 칼로 찌르듯인가요, 전기가 통하듯인가요, 둔하고 빠르나요? 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 하면 몇 점인가요?

양상 하나로 신경성과 근골격성이 갈려요. NRS는 중증도와 응급성을 재고요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
전기가 통하듯 다리로	요추간판탈출증	눌린 신경 섬유의 이상 방전이다
둔하고 빠르	요추염좌·근육통	근육과 인대의 손상은 둔통으로 나타난다
깊고 쑤신다·밤에 심함	종양·감염	조직 자체의 병변은 자극과 무관하게 아프다
쥐어짜듯 옆구리	요로결석	요관 경련이 만드는 산통이다
8점 이상·갑자기	골절·대동맥류	급성 구조 파괴는 극심한 통증을 만든다

6-5. A – 일곱 줄, 그중 하나는 응급

A 전신 MUST

발열이나 오한이 있나요? 피로하거나 체중이 변하지는 않았나요?

발열은 척추 감염을, 체중 감소는 암 전이를 지목해요. 두 red flag를 한 줄로 훑어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
열이 난다	척추 감염 · 농양 · 신우신염	감염이 전신 반응을 만든다
체중이 빠진다	척추 종양 · 전이	악성 질환의 소모 증상이다
전신 증상 없음	근골격 · 신경학적	국소 원인이면 전신 반응이 생길 이유가 없다

A 마미증후군 MUST

소변이나 대변이 새지는 않나요? 항문 주위나 사타구니 감각이 둔하지는 않나요?

이 CC의 유일한 응급을 거르는 줄이에요. 묻지 않으면 환자가 먼저 말하지 않는 경우가 많아요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
소변 · 대변이 샌다	마미증후군	방광과 직장을 담당하는 뿌리가 다발 아래쪽에 모여 있다
항문 주위 · 회음부 감각이 둔하다	마미증후군	안장에 닿는 부위를 담당하는 뿌리가 함께 눌린다
양쪽 다리에 힘이 없다	마미증후군	다발이 통째로 눌리면 좌우가 함께 나빠진다
없다	응급 배제	다만 증상이 진행할 수 있으므로 교육에서 반드시 알려준다

A 추간판탈출증 MUST

다리 힘이 약해지거나 감각이 둔하지는 않나요?

신경 침범의 진행 신호예요. 저림은 초기, 근력 저하는 진행이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
발끝으로 서기가 안 된다	S1 뿌리 병변	해당 뿌리가 담당하는 근육의 힘이 빠진다
발목을 못 젖힌다	L4~L5 뿌리 병변	전경골근을 담당하는 뿌리가 눌린다
특정 발가락만 둔하다	해당 뿌리 병변	피부분절이 병소의 높이를 지목한다
없다	신경 침범 근거 약함	다만 방사통만 있어도 신경학적 이상 칸에 남긴다

A 척추관협착증 MUST

걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하나요? 쉬면 다시 걸을 수 있나요?

파행을 확인해요. 자세 의존성까지 같이 물으면 혈관성 파행과 갈려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
걷다 쉬고 다시 걷는다	파행 · 척추관협착증	보행 자세에서 통로가 좁아져 증상이 나온다
앉아서 쉬어야 편하다	신경성 파행	굽힌 자세가 통로를 넓혀 준다
서서 쉬어도 좋아진다	혈관성 파행	자세와 무관하고 혈류 회복만으로 좋아진다
카트를 밀면 오래 걷는다	척추관협착증	굽힌 자세를 유지하면 통로가 열려 있다

A 강직척추염 MUST

아침에 허리가 뻣뻣한가요? 얼마나 지속되나요? 눈이 빨개지고 아픈 적은요? 설사나 복통은 어떠신가요?

염증성 요통과 관절 밖 침범을 함께 훑어요. 포도막염이 나오면 안과 검진을 추가해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
아침에 한 시간 넘게 뻣뻣	강직척추염	밤새 고인 염증성 삼출액이 아침에 흩어지는 데 시간이 걸린다
눈이 빨개지고 아팠다	포도막염 동반	같은 면역 축을 공유해 관절 밖 침범이 흔하다
설사 · 복통이 있다	염증성 장질환 동반	척추관절병증군은 장 염증과 함께 오기도 한다
없다	강직척추염 가능성 낮음	염증성 요통의 핵심 소견이 빠진다

A 정신 SHOULD

요즘 기분은 어떠신가요? 우울하거나 의욕이 없지는 않으신가요?

만성 요통과 기분 증상은 서로를 악화시켜요. 치료 계획에도 영향을 줍니다.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
우울하다	만성 통증 · 기분 증상 동반	통증과 우울은 양방향으로 서로를 악화시킨다
일상에 지장이 크다	기능 저하	치료 목표를 통증 감소가 아니라 기능 회복으로 잡는다
괜찮다	특이 소견 없음	신체 원인에 집중한다

A 척추 염좌 SHOULD

허리를 굽히기 어려운가요?

굽힘 제한은 근육과 인대의 손상을 시사해요. 압박골절에서도 나올 수 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
굽히기 어렵다	요추염좌 · 압박골절	손상된 조직에 장력이 걸려 아프다
젖히기가 더 어렵다	척추관협착증	젖히면 통로가 좁아져 증상이 나온다
양쪽 다 어렵다	강직척추염 · 진행된 구조 변화	척추 마디가 굳으면 모든 방향이 제한된다

6-6. F · E · 외 · 과 · 약 · 사 · 가 · 여

F 자세 · 운동 MUST

통증을 악화시키거나 완화시키는 요인이 있나요? 특별히 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? 휴식 시 완화되나요, 아니면 움직이면 완화되나요?

허리에서 가장 무거운 항목이에요. 질문 두 개가 네 질환을 정리해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
젖히면 악화 · 앉으면 완화	척추관협착증	젖히면 통로가 좁아지고 굽히면 넓어진다
굽히면 악화 · 기침하면 악화	요추간판탈출증	굽힘과 복압 상승이 추간판과 신경뿌리를 더 누른다
움직이면 악화 · 쉬면 완화	요추염좌 · 압박골절	손상 조직에 장력이 걸려야 아프다
쉬면 악화 · 움직이면 완화	강직척추염	고인 염증성 삼출액이 움직임으로 흘러진다
자세와 무관	종양 · 감염 · 연관통	기계적 자극과 무관하면 다른 원인을 봐야 한다

E 건강검진 DROP

이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? 골밀도 검사를 받아보신 적 있나요?

골다공증 검사 여부는 압박골절의 배경이 돼요. 그 점에서만 의미가 있어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
골밀도가 낮다고 들었다	골다공증 · 압박골절	골강도가 낮으면 가벼운 힘에도 척추체가 무너진다
검사한 적 없다	정보 없음	고령이나 폐경이면 검사를 권할 수 있다
특별한 건 없었다	정보 없음	예상되는 가장 흔한 답이다

외 수술 · 외상 MUST

허리 수술을 받으신 적 있으세요? 허리를 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?

외상 사건은 골절을 세우고, 다른 부위 골절력은 골다공증을 시사해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
넘어진 뒤부터	요추압박골절	낮은 에너지 손상에서 골절되면 골강도가 낮다
허리 수술 이력	수술 후 변화 · 인접부 문제	수술 부위 위아래에 부하가 옮겨 간다
손목이나 고관절 골절 이력	골다공증	이전 골절 자체가 다음 골절의 강한 위험인자다
없다	외상성 배제	구조물 손상 가설이 약해진다

과 과거력 MUST

이전에 진단 받은 병이 있나요? 고혈압, 당뇨, 결핵, 류마티스 질환, 골다공증, 암은 어떠신가요?

암은 척추 전이를, 결핵은 척추 감염을, 골다공증은 압박골절을, 당뇨는 감염 위험을 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
암 진단을 받은 적 있다	척추 전이	폐 · 유방 · 전립선암이 척추로 잘 전이된다
결핵을 앓은 적 있다	척추 결핵	감염이 척추체를 침범하면 만성 통증으로 온다
골다공증	요추압박골절	골강도가 낮으면 가벼운 힘에도 무너진다
당뇨 · 면역저하	척추 감염 · 농양	면역이 떨어지면 균이 자리 잡기 쉽다
궤양성 대장염	강직척추염 동반	같은 면역 축을 공유하는 질환군이다

약 약물 SHOULD

현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 통증이 호전되나요?

스테로이드 장기 복용은 골강도를 떨어뜨리고, 치료 반응은 진단 정보가 돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
스테로이드 장기 복용	골다공증 · 압박골절	골형성이 억제되어 골강도가 떨어진다
소염진통제에 반응	염증성 · 근골격	약물 반응성이 간접 근거가 된다
진통제로 조절 안 됨	종양 · 감염 · 신경병증	기전이 달라 일반 진통제가 듣지 않는다
복용 약 없음	특이 배경 없음	약물 관련 요인을 배제한다

사 생활 · 근무 자세 · 운동 SHOULD

술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요? 운동은 하시나요? 최근에 격한 운동을 하셨나요?

요추 부하의 배경이자 교육에서 교정할 대상이에요. 흡연은 추간판 영양에도 좋지 않아요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
무거운 것을 자주 든다	요추염좌 · 추간판탈출증	반복 부하가 근육과 추간판에 손상을 누적시킨다
오래 앉아 일한다	추간판 부하	앉은 자세가 서 있을 때보다 추간판 압력을 높인다
운동을 전혀 안 한다	근력 약화 · 진행 인자	허리 주위 근육이 약하면 척추가 부하를 그대로 받는다
최근 격한 운동	염좌 · 골절	갑작스러운 부하가 손상을 만든다
흡연	추간판 퇴행 · 골밀도 저하	혈류와 영양 공급에 불리하게 작용한다

가 가족력 SHOULD

가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요? 류마티스 질환이나 척추, 신경계 질환이 있는 분은요?

강직척추염은 HLA-B27 연관이라 가족 집적성이 뚜렷해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
젊은 남자 형제가 허리가 아프다	강직척추염	HLA-B27 연관 질환이라 가족 안에서 반복된다
류마티스 질환 가족력	자가면역 질환군	감수성 배경을 공유한다
없다	사전 확률 낮음	배제는 못 하지만 순위가 내려간다

여 폐경 DROP

폐경은 언제 하셨나요?

골다공증 배경으로만 의미가 있어요. 압박골절 케이스에서는 SHOULD로 올라가요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
폐경 후	골다공증 · 압박골절 위험	에스트로겐 감소가 골소실을 가속한다
해당 없음	정보 없음	감별에 추가 정보를 주지 않는다

스스로 답해보기

Q A 일곱 줄 중 응급을 담당하는 줄과 그 세 질문은?

Q F의 두 질문이 어떻게 네 질환을 정리하는가?

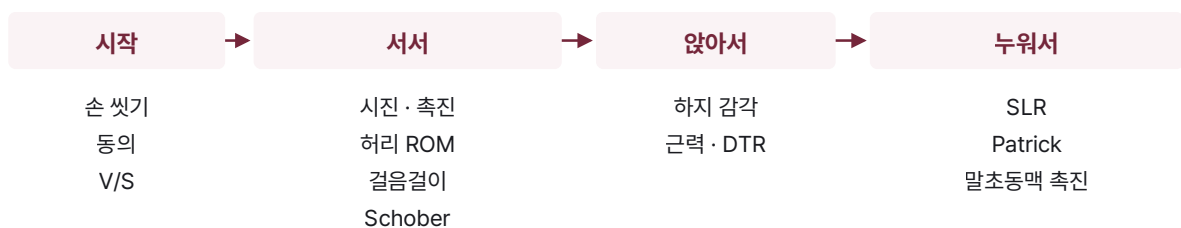
PART 7

Physical examination

허리 진찰은 세 자세를 다 써요. 서서, 앉아서, 누워서. 자세를 어떻게 배치하느냐가 시간을 결정합니다.

그리고 **SLR**과 **Patrick**은 반드시 양측 모두 시행해야 해요. 각각 추간판탈출증과 강직척추염을 겨냥하는데, 한쪽만 하면 비교 기준이 없어서 판정이 안 됩니다. 강직척추염이 의심되면 Schober test가 추가로 필요하고요.

7-1. 동선



이 동선의 함정

베드에 바로 눕히는 진찰과 옆드려서 하는 진찰이 다르므로 미리 정해 둔다
SLR과 Patrick은 반드시 양측 모두 각각 추간판탈출증과 강직척추염을 겨냥하다

서서 넷, 앉아서 하나, 누워서 셋. 자세를 한 번씩만 바꾼다

- 시작**
손 씻기 › 진찰 동의 › 오늘 측정할 활력 징후는 정상입니다.
- 서서**
허리를 보기 위해 상의를 올려주세요. 통증 부위 시진 · 촉진. **압통 여부와 척추의 만곡 정도**를 함께 봐요.
- 서서**
허리 ROM 평가. 굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전. **extension 제한**은 척추관협착증을 시사해요.
- 서서**
걸음걸이 시진. 저기까지 걸어갔다 오세요. 파행과 보행 이상을 눈으로 봐요.
- 서서**
Schober test. 강직척추염이 의심되면 chest expansion test를 추가해요.
- 앉아서**
하지 감각 · 근력 · DTR(무릎, 발목) 평가. 양측 비교로요.
- 누워서**
SLR test › Patrick test. **반드시 양측 모두**.
- 누워서**
말초동맥 맥박 촉진. 척추관협착증이 의심되면 혈관성 파행을 배제할 목적으로 해요.
- 마무리**

협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

왜 이 순서일까요? **자세 전환을 세 번으로 끝내기 위해서예요.** 서서 할 수 있는 넷을 다 하고, 침대에 앉혀 신경학적 검사하고, 마지막에 눕혀 특이검사를 몰아서 해요. 베드에 바로 눕히는 진찰과 엎드려서 하는 진찰이 다르므로 미리 정해 두어야 허둥대지 않아요.

7-2. 진찰마다 무엇을 잡나

진찰	무엇을 보는가	지목하는 질환
시진	척추 만곡 · 측만 · 피부 병변	구조 변형 · 강직척추염의 후만
촉진	압통점, 극돌기 압통	요추염좌 · 압박골절 · 감염
허리 ROM	굴곡 · 신전 · 측방굴곡 · 회전	extension 제한은 협착증, 전방향 제한은 강직척추염
걸음걸이	파행 · 발끝 · 발뒤꿈치 보행	협착증 · 뿌리별 근력 저하
하지 감각	L4 · L5 · S1 피부분절	저린 부위가 병소의 높이를 지목
하지 근력	발목 젖히기 · 엄지 젖히기 · 발끝 서기	근력 저하는 신경 침범의 진행 신호
DTR	무릎 · 발목 반사	저하는 뿌리 병변, 양측 저하는 마미증후군
SLR	좌골신경 견인	요추간판탈출증
Patrick	고관절 · 천장관절	반대측 통증이면 강직척추염
Schober	요추 굴곡 범위	강직척추염
말초동맥 맥박	하지 혈류	혈관성 파행 배제

7-3. 특이검사 카드

하지직거상 검사 Straight leg raise, SLR

환자 자세

누워서. 무릎을 편 채로. 반드시 양측.

내 손동작

1. 한 손으로 발뒤꿈치를 받치고 다른 손을 무릎 위에 얹어 무릎이 굽지 않게 눌러요.
2. 다리를 천천히 들어 올려요.
3. 환자가 아프다고 하는 각도에서 멈추고 그 각도를 기억해요.
4. 반대쪽 다리도 같은 방식으로 해서 비교해요.

양성 판정

들어 올리는 도중 허리에서 다리로 뻗치는 통증이 재현되면 양성이에요. 허벅지 뒤가 당기기만 하는 건 양성이 아니에요.

무엇을 잡나

다리를 들면 좌골신경이 위로 당겨지고, 눌러 있던 신경뿌리가 더 팽팽해져 원래의 방사통이 재현돼요.

흔한 실수

무릎이 굽으면 신경이 안 당겨져 음성으로 나와요. 그리고 당김과 방사통을 구분 못 하면 과잉 양성이 됩니다.

패트릭 검사 Patrick test, FABER

환자 자세

누워서. 반드시 양측 모두.

내 손동작

1. 한쪽 다리를 굽혀 발목을 반대쪽 무릎 위에 올려 숫자 4 모양을 만들어요.
2. 한 손으로 반대쪽 골반을 눌러 침대에 고정해요.
3. 다른 손으로 굽힌 쪽 무릎을 바깥 아래로 천천히 눌러요.
4. 반대쪽도 같은 방식으로 시행해 비교해요.

양성 판정

누른 쪽 사타구니가 아프면 고관절 문제, 반대쪽 엉치가 아프면 천장관절 문제예요. 강직척추염에서는 반대쪽이 아파요.

무엇을 잡나

고관절을 굽히고 벌리고 바깥으로 돌리면서 천장관절에 비틀림을 줘요. 어느 쪽이 아픈지가 병소를 지목합니다.

흔한 실수

반대쪽 골반을 안 누르면 골반 전체가 같이 돌아가 천장관절에 힘이 안 걸려요. 그리고 아픈 쪽만 물어보면 어느 관절인지 못 가려요.

쇼버 검사 Schober test

환자 자세

서서. 환자 등을 볼 수 있게 뒤에 서요.

내 손동작

1. 양쪽 골반 위쪽 뼈를 잇는 선이 척추와 만나는 지점을 찾아 표시해요.
2. 거기서 위로 10cm, 아래로 5cm 되는 지점에 각각 표시해요.
3. 환자에게 무릎을 편 채로 허리를 최대한 숙이라고 해요.
4. 숙인 상태에서 위아래 표시 사이의 거리를 다시 재요.

양성 판정

늘어난 거리가 **5cm 미만**이면 양성이에요. 정상이면 5cm보다 더 늘어나요.

무엇을 잡나

요추가 굽으면 척추뼈 사이가 벌어지면서 피부도 같이 늘어나요. 강직척추염으로 척추가 굳으면 이 늘어남이 사라집니다.

흔한 실수

무릎을 굽히면 허리를 안 굽혀도 손이 내려가 결과가 왜곡돼요. 그리고 표시를 안 하고 눈대중으로 하면 못 재요.

흉곽 확장 검사 Chest expansion test

환자 자세

서서. 강직척추염이 의심될 때 추가로.

내 손동작

1. 줄자를 네 번째 갈비뼈 높이에서 가슴 둘레에 감아요.
2. 숨을 최대한 내쉬 상태에서 둘레를 재요.
3. 숨을 최대한 들이쉬 상태에서 다시 재요.
4. 두 값의 차이를 계산해요.

양성 판정

들숨과 날숨의 차이가 **줄어 있으면** 양성이에요. 흉곽 확장이 제한된 겁니다.

무엇을 잡나

강직척추염은 갈비뼈와 척추가 만나는 관절에도 염증을 일으켜요. 그 관절이 굳으면 숨 쉴 때 흉곽이 벌어지지 못합니다.

흔한 실수

갈비뼈 높이를 잘못 잡거나, 환자가 어깨를 들썩이며 숨을 쉬면 값이 부정확해져요.

하지 신경학적 검사 Lower limb neuro exam

환자 자세

침대에 앉아서. 반드시 양측 비교.

내 손동작

1. 감각 - L4 정강이 안쪽, L5 엄지발가락과 발등, S1 새끼발가락과 발바닥을 좌우 비교해요.
2. 근력 - 발목 젖히기(L4~L5), 엄지 젖히기(L5), 발끝으로 서기(S1).
3. DTR - 무릎 반사와 발목 반사를 해머로 제대로 쳐요.
4. 마미증후군이 의심되면 회음부와 항문 주위 감각을 확인해요.

양성 판정

특정 뿌리 구역만 나쁘면 그 높이의 신경뿌리 병변, 양쪽 근력과 반사가 함께 떨어지면 마미증후군을 의심해요.

무엇을 잡나

각 신경뿌리가 담당하는 피부 구역과 근육이 정해져 있어요. 어느 구역이 나쁘지가 병소의 높이를 알려줍니다.

흔한 실수

근력을 숫자로만 재려다 시간을 태우는 것. 발끝 서기와 발뒤꿈치 걷기가 훨씬 빠르고 정확해요. 그리고 양측 비교를 빼면 기준이 없어요.

말초동맥 맥박 촉진 Peripheral pulse palpation

환자 자세

누워서. 척추관협착증이 의심될 때.

내 손동작

1. 대퇴동맥을 사타구니 중앙에서 만져요.
2. 오금동맥을 무릎 뒤에서 만져요.
3. 발등동맥과 뒤정강동맥을 발에서 만져요.
4. 양쪽을 비교해요.

양성 판정

맥박이 약하거나 만져지지 않으면 혈관성 파행을 의심해요. 정상이면 신경성 파행 쪽입니다.

무엇을 잡나

걷다가 쉬는 증상은 신경이 눌러서일 수도, 혈류가 부족해서일 수도 있어요. 맥박이 그 둘을 갈라 줍니다.

흔한 실수

척추관협착증을 진단해 놓고 이 촉진을 건너뛰는 것. 혈관성 파행을 놓치면 치료 방향이 통째로 틀려요.

7-4. 감점 포인트

- SLR이나 Patrick을 한쪽만 시행함. 양측이어야 비교가 됩니다
- SLR에서 허벅지 뒤 당김을 양성으로 읽음
- Schober test에서 무릎을 굽히게 함
- 척추관협착증을 의심하면서 말초동맥 맥박을 안 만짐
- 마미증후군이 의심되는데 회음부 · 항문 주위 감각을 확인하지 않음
- 하지 감각 · 근력 · 반사를 양측 비교하지 않음

- 걸음걸이 시진을 건너뛸. 파행은 눈으로 보는 게 가장 빨라요
 - 자세를 여러 번 바꾸며 시간을 태움
 - 상의를 올려 달라고 하지 않고 옷 위로 만짐
 - 손 씻기 · 진찰 동의 · V/S 언급 누락
-

스스로 답해보기

- Q SLR에서 허벅지 뒤 당김을 왜 양성으로 읽으면 안 되는가?
 - Q Patrick에서 아픈 쪽과 반대쪽이 각각 무엇을 의미하는가?
 - Q 척추관협착증에서 말초동맥 맥박을 만지는 이유는?
-

PART 8

검사 계획

기본은 두 줄. 영상과 근전도예요.

검사	왜 · 언제	근거
L-spine X-ray (AP, lateral)	거의 모든 케이스의 기본. 정렬 · 골절 · 전방전위 · 퇴행 변화	[관행]
L-spine CT / Lumbosacral MRI	신경학적 이상이 있거나 red flag가 있을 때. 마미증후군이면 즉시	[GL]
근전도 EMG	신경뿌리 병변의 높이와 정도를 확인할 때	[GL]
HLA-B27 · ESR · CRP	젊은 남성의 염증성 요통. 강직척추염이 의심될 때	[GL]
골반 X-ray	천장관절염 확인	[상황부]
안과 검진	강직척추염에서 포도막염이 동반될 수 있어 예약해 드려요	[상황부]
골밀도 검사	압박골절이 의심되거나 고령 · 폐경 여성일 때	[상황부]
소변검사 · 복부 영상	연관통이 의심될 때. 신우신염 · 결석 · 복부 질환	[상황부]
마미증후군인데 영상을 나중에	배뇨 기능은 늦으면 돌아오지 않아요	[금기]

8-1. 치료 계획

공통 축 – 안정, 견인, 소염진통제, 국소주사요법, 수술

진단	치료
요추염좌	안정, 물리 치료
추간판탈출증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
척추협착증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
암의 척추 전이	전이암에 대한 고식적 치료(수술, 방사선 치료), 원발암 조절(항암 치료)
마미증후군	응급 수술로 완전히 감압
강직척추염	NSAID, infliximab, sulfasalazine / 검사는 ESR, CRP, HLA-B27
요추 압박 골절	수술, 골다공증 치료

PART 9

Education

가장 흔한 요추염좌는 안심시키는 것 자체가 치료의 일부예요.

9-1. 교육 대사의 뼈대

단계

말할 문장

공감	허리 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 요추간판탈출증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 허리 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 요추염좌나 척추관협착증 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 허리 X-ray, 허리 CT와 MRI가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요?
검사 (강직척추염)	허리 X-ray와 혈액 염증 수치를 확인하겠습니다. 그리고 눈에 염증이 같이 동반되는 경우가 많기 때문에 안과 검진도 같이 예약해 드리겠습니다.
치료	만약 검사로 요추간판탈출증이 확인되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

9-2. 진단별 한 마디

진단

환자에게 할 설명

요추염좌	허리 근육과 인대가 늘어난 상태입니다. 대개 2주 정도면 좋아지니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 다만 무리한 활동은 잠시 줄이시고, 진통제와 온찜질로 통증을 줄여 드리겠습니다.
요추간판탈출증	척추뼈 사이의 물렁뼈가 밀려 나와 신경을 누르는 상태입니다. 대부분은 시간이 지나며 줄어들기 때문에 우선 약과 물리 치료로 좋아지기를 기다립니다.
척추관협착증	신경이 지나가는 통로가 좁아진 상태입니다. 허리를 젖히면 더 좁아지고 굽히면 넓어져서, 앉으면 편해지는 겁니다. 자세를 아는 것만으로도 생활이 훨씬 편해집니다.
마미증후군	여러 신경이 한꺼번에 눌러 소변 기능까지 영향을 받는 상태로 의심됩니다. 늦어지면 회복이 어려울 수 있어 바로 검사하고 응급으로 치료해야 합니다.
강직척추염	척추와 골반을 잇는 관절에 염증이 생기는 병입니다. 쉬면 더 아프고 움직이면 나아지는 게 특징입니다. 운동과 재활이 그만큼 중요합니다.

9-3. 이런 증상이면 즉시 오세요

갑자기 배변이나 배뇨에 장애가 생길 때 **최우선**

다리 힘이 빠지거나 감각이 저하될 때

걸기가 힘들어질 때

열이 나면서 허리가 심하게 아플 때

9-4. 생활교육

교육

왜 이렇게 말하나

안정과 적당한 운동을 함께	완전한 안정은 근력을 떨어뜨려요. 스트레칭을 포함한 적당한 운동이 필요합니다
항상 바른 자세로	서 있거나 앉았을 때의 자세가 허리에 걸리는 부하를 결정해요. 좋지 않은 자세는 통증을 더 심화시킵니다
안내 책자와 규칙적 운동	바른 자세와 허리 통증을 줄이는 운동법이 적힌 자료를 드리고, 집에서 규칙적으로 따라 하도록 합니다
근무 환경의 자세 교정	하루 대부분을 보내는 자세가 질환을 악화시켜요
요추염좌라면 안심시키기	2주 정도면 괜찮아진다고 알려 주면서 동시에 무리한 활동은 제한해요
강직척추염이면 안과 검진	포도막염이 동반될 수 있어 안과 검사가 추가로 필요할 수 있어요
암 전이 등 신경학적 이상	심한 신경학적 이상이 발생하면 방사선 치료나 수술 같은 응급 조치가 필요함을 알려요

9-5. PPI 대사 बैं크

상황

준비 문장

오프닝	허리가 아프시면 앉고 서는 것도 힘드셨을 것 같습니다. 천천히 말씀해 주세요.
방사 경로 확인	통증이 어디서 시작해서 어디까지 가는지 손으로 한번 그려 주시겠어요?
민감한 질문 전	혹시 불편하시겠지만 진단에 꼭 필요해서 여쭙겠습니다. 소변이나 대변이 새지는 않으셨나요?
진찰 전 안내	허리를 보기 위해 상의를 올려주시겠어요? 조심해서 살펴보겠습니다.
걸음걸이 요청	저기까지 한번 걸어갔다 와 주시겠어요? 걸으실 때 어떤지 보려고 합니다.
SLR 전	다리를 천천히 들어 올릴 텐데, 허리에서 다리로 뻗치는 느낌이 있으면 바로 말씀해 주세요.
안심시키기	대부분의 허리 통증은 2주 정도면 좋아집니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.
수술 걱정	바로 수술하는 경우는 많지 않습니다. 우선 약과 물리 치료로 좋아지기를 기다려 봅시다.
클로징	제가 말씀드린 것 중에 더 궁금하신 점 있으실까요?

PART 10

케이스 통합 연습

가장 흔한 것과 유일한 응급으로 대비되는 둘.

10-1. 케이스 A – 가장 흔한 것

환자

서른네 살 남자입니다. 어제 이사하면서 무거운 짐을 들다가 허리를 삐끗했어요.

허리 근육이 뻣근하고 구부리기가 힘듭니다.

다리로 내려가거나 저리진 않아요. 소변도 정상이고요.

열은 없고 체중도 그대로입니다.

㉠ 관문 두 층 통과

배뇨·배변 정상, 양쪽 다리 정상 > **마미증후군 배제**. 발열 없음, 체중 변화 없음, 야간통 없음, 복부·옆구리 증상 없음 > **종양·감염·연관통 배제**.

㉡ 대축

다리로 안 내려가고 저림도 없어요. **신경 외 근골격 칸**. 사건이 무거운 짐이고 움직이면 악화되니 요추염좌예요.

㉢ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
A 척추 염좌	굽히기 어려운지	근육·인대 손상을 확인
F 운동	움직이면 악화·쉬면 완화	기계적 요통 확정. 강직척추염과 반대
외	다른 부위 골절력	골다공증 배경 확인
사	직업·근무 자세	재발 방지 교육의 재료
Ex	이전 삽화	만성 재발성인지

㉣ 진찰과 계획

서서 시진·촉진(압통점) > 허리 ROM > 걸음걸이 > 앉아서 하지 감각·근력·DTR(정상일 것) > 누워서 **SLR 음성 확인**과 Patrick. 검사는 L-spine X-ray. 교육은 **2주면 좋아진다고 안심시키기** + 무리한 활동 제한 + 진통제와 온찜질 + 바른 자세.

점수를 만든 지점 – 마미증후군을 명시적으로 물어 배제한 것, 방사통 없음을 확인해 대축을 넘긴 것, SLR 음성을 확인해 추간판탈출증을 지운 것, 그리고 안심시키는 교육을 한 것.

10-2. 케이스 B – 유일한 응급

환자

쉰두 살 남자입니다. 일주일 전부터 허리가 아프더니 어제부터 심해졌어요.

양쪽 다리에 힘이 없고 걷기가 힘듭니다.
오늘 아침에 소변이 저도 모르게 샀어요.
엉덩이 쪽하고 사타구니 감각이 둔합니다.

㉠ 관문 1에서 바로 걸려요

요실금 + 양쪽 다리 근력 저하 + 안장 부위 감각 마비. **대축을 돌리기 전에 마미증후군으로 방향이 정해집니다.** 요추간 판탈출증으로 접근해 보존적 치료를 말하면 케이스 전체가 틀려요.

㉡ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
A 마미증후군	요실금 · 변실금 · 항문 주위 감각	세 가지가 모이면 응급 확정
L	양쪽인지	양측이면 다발이 눌린 것
O	언제부터 소변 증상이	시간이 곧 기능이라 발생 시점이 중요
A 전신	발열 · 체중 변화	종양이나 감염이 원인인지
과	암 병력	전이성 병변 가능성

㉢ 진찰과 계획

허리 진찰에 시간을 오래 쓰지 않아요. **양하지 근력 · 심부건 반사 저하와 회음부 · 항문 주위 감각**을 확인하고 바로 방향을 튼다. 검사는 **L-spine MRI를 즉시**. 교육은 응급 수술로 완전히 감압해야 하는 이유, 그리고 늦으면 배뇨 기능이 돌아오지 않을 수 있다는 것.

점수를 만든 지점 – 소변 증상을 명시적으로 물은 것, 양쪽임을 확인한 것, 회음부 감각을 진찰에 넣은 것, 보존적 치료가 아니라 응급 수술로 계획을 튼 것.

두 케이스의 대비가 말해 주는 게 있어요. A는 **없는 것을 확인**해서 진단이 됐고, B는 **있는 것 하나**가 모든 걸 뒤집었어요. 그래서 마미증후군 줄은 케이스가 아무리 전형적인 염좌로 보여도 반드시 던져야 해요.

PART 11

3속도 복습

11-1. 시험 직전 1분 압축표

질환	등 어리	결정 단서	진단	치료
요추염좌	근골격	무거운 짐 · 빠곳, 신경학적 검사 정상, 압통점	L-spine X-ray	안정, 물리 치료, 요추 보조기
요추간판탈출증	신경학적	요통 + 편측 하지 통증 · 저림, SLRT(+)	L-spine X-ray, CT/MRI	침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술
척추관협착증	신경학적	파행, 젖히면 악화 · 앉으면 경감, extension 제한	L-spine X-ray, CT/MRI	침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술
척추 종양	종양	암 병력, 체중 감소, 야간 통증, 하지 감각 · 근력 이상	L-spine X-ray, CT/MRI	방사선, 항암, 수술
마미증후군	응급	요실금 · 변실금, 양하지 근력 · 반사 저하, 안장 감각 마비	L-spine MRI	응급 수술로 완전히 감압
강직척추염	류마티스	20~30대 남자, 조조강직, 운동 완화 · 휴식 악화, 포도막염	Lumbar X-ray, HLA-B27, ESR, CRP	NSAID, 재할 · 운동, Infiximab
요추압박골절	근골격 · 뼈	골다공증, 넘어짐, 요통, 요추부 운동 제한	L-spine X-ray, CT/MRI	요추보조기, NSAID, Opioid, 골다공증 치료, 수술
골관절염	류마티스 · 기타	Crepitus, 조조강직 30분 미만, 50세 이상, ROM 감소	-	NSAID, 재할 · 운동, 생활 습관 개선

11-2. 미니케이스

상황	답
무거운 짐 들다 빠곳, 다리로 안 내려가요 의심 · 교육 한 줄	요추염좌 · 2주 정도면 괜찮아진다고 안심시키고 무리한 활동 제한
한쪽 다리로 내려가고 기침하면 심해져요 의심 · 진찰 1	요추간판탈출증 · SLR test 양측
백 미터 걸으면 쉬어야 하고 앉으면 편해요 의심 · 반드시 추가할 진찰	척추관협착증 · 말초동맥 맥박 촉진으로 혈관성 파행 배제
소변이 새고 양쪽 다리에 힘이 없어요 다음 행동	마미증후군 · 회음부 감각 확인 후 L-spine MRI 즉시, 응급 수술 감압
28세 남자, 아침에 뻣뻣하고 움직이면 나아져요 의심 · 진찰 2 · 추가 검진	강직척추염 · Schober, Patrick 반대측 통증 · 안과 검진 예약

상황

답

골다공증 있는 70대가 살짝 넘어진 뒤 허리가 아파요
의심 · 검사

요추압박골절 · L-spine X-ray, 필요 시 CT/MRI, 골밀도

암 병력이 있고 밤에 더 아프고 체중이 빠져요
의심 · 왜 야간통이 중요한가

척추 종양 · 자극과 무관하게 아프면 조직 자체의 병변이에요

옆구리가 아프고 열이 나며 소변에 피가 섞여요
의심 · 어느 층인가

신우신염 · 요로결석 · 허리가 아니라 **연관통** 층이에요

11-3. Active recall

왜 만 모았어요

- Q 왜 허리에는 목에 없는 연관통 층이 있는가?
- Q 왜 마미증후군은 양쪽에 오는가?
- Q 왜 마미증후군에서 소변 증상이 먼저 티가 나는가?
- Q 왜 요추간판탈출증은 한쪽에만 오는가?
- Q 왜 기침할 때 추간판탈출증이 심해지는가?
- Q 왜 척추관협착증은 앉으면 편해지는가?
- Q 왜 척추관협착증에서 증상은 심한데 진찰이 정상인가?
- Q 신경성 파행과 혈관성 파행을 가르는 질문 두 개는?
- Q 왜 강직척추염은 쉬면 더 아픈가?
- Q 왜 강직척추염에서 눈과 장을 함께 묻는가?
- Q 왜 SLR에서 무릎을 편 채로 들어야 하는가?
- Q 왜 Patrick에서 반대쪽 골반을 눌러 고정하는가?
- Q 왜 요추염좌에서 안심시키는 것이 치료의 일부인가?

PART 12

대본 전문

항목	말할 문장	등급
O	언제부터 허리가 아팠나요? 갑자기 or 서서히?	MUST
O	특히 어떤 상황에서 통증이 시작되었나요? (기침, 넘어짐, 허리 삐끗, 걷다가)	MUST
L	통증이 있는 부위가 어디인가요? 짚어보시겠어요?	MUST
L	허리 외에 아픈 곳은 없나요?	MUST
L	통증이 어디로 뻗어나요?	MUST
D	통증이 얼마나 지속되나요?	SHOULD
D	하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?	SHOULD
Co	통증이 점점 더 심해지나요?	DROP
Ex	이전에도 통증이 있었나요? 그때 병원에서 진단을 받으셨나요?	SHOULD
Ex	진통제나 파스를 쓰셨나요? 효과가 있던가요?	SHOULD
C	통증이 어떤 양상인가요? (칼로 찌르듯이 / 전기가 통하듯이 / 둔하고 빠근)	MUST
C	압통(T)/발적(R)/종창(S)/열감(H)/움직일 때 소리(C)/움직임 제한(L)이 있나요?	DROP
C	안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 했을 때 몇 점인가요? (NRS)	MUST
A 전신	발열 / 오한 / 피로 / 체중 변화(암 전이)	MUST
A 추간판탈출증	다리 근력 저하 / 감각 저하	MUST
A 척추관협착증	파행 - 걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하나요?	MUST
A 마미증후군	요실금 / 변실금 / 항문 주위 감각 이상	MUST
A 강직척추염	조조강직 / 포도막염 / 설사 / 복통	MUST
A 정신	우울	SHOULD
A 척추 염좌	허리를 굽히기 어려운가요?	SHOULD
F 자세	특히 통증이 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? (굽힘 / 젖힘)	MUST
F 운동	휴식 시 통증이 완화되나요? 아니면 움직이면 완화되나요? (류마티스 질환)	MUST
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?	DROP
외 수술	허리 수술 받으신 적 있으세요?	MUST
외 외상	허리를 다친 적이 있나요? 다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?	MUST

항목	말할 문장	등급
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/결핵/류마티스 질환/골다공증/암)	MUST
약	현재 복용 중인 약물이 있나요? 진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 호전되나요?	SHOULD
사	술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요?	SHOULD
사	운동을 많이 하시는 편인가요? 최근에 격한 운동을 한 적이 있나요?	SHOULD
사	직업이 어떻게 되시나요? 근무 시 주로 어떤 자세인가요?	SHOULD
사	스트레스를 많이 받으시나요?	SHOULD
가	가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요?	SHOULD
가	가족 중에 류마티스 질환 / 척추 / 신경계 질환이 있는 분이 있나요?	SHOULD
여	폐경	DROP

12-1. P/E 전문

구분	항목
도입	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정할 활력 징후는 정상입니다.
서서 1	허리를 보기 위해 상의를 올려주세요. 통증 부위 사진 / 촉진 (압통 여부, 척추의 만곡 정도 확인)
서서 2	허리 ROM 평가 (flexion, extension, lateral bending, rotation)
서서 3	걸음걸이 사진 – 저기까지 걸어갔다 오세요.
서서 4	Schober test – 허리를 폼 때와 굽혔을 때 늘어나는 거리 측정 (정상 5cm 초과). AS 의심 시 chest expansion test 추가
앉아서 5	하지 감각 / 근력 / DTR(무릎, 발목) 평가
누워서 6	SLR test, Patrick test – 반드시 양측 모두 시행하여 각각 HIVD, AS 감별
누워서 7	말초동맥 맥박 촉진 – 척추관협착증 의심 시 혈관성 파행 배제 목적
마무리	협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

12-2. keyword

허리 통증도 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염 · 종양 · 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 – 통증의 양상 / 강도 / 다른 부위 통증 + 동반 증상(요실금, 포도막염 등), 과거 치료 여부 및 반응, 수술 / 약물 / 직업 / 운동 / 골다공증 과거력

악화 요인 – 휴식 · 아침에 악화(강직척추염) ↔ 걸을 때(요추염좌), 자세 변화(요추간판탈출증, 척추관협착증)

신체 진찰 – 상지 · 하지 감각 · 근력 · DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Schober, 허리 ROM 평가, 시진 · 촉진, (누워서) SLR, Patrick

교육 – 보존적 치료(물리 치료 · 보조기 · 진통제 · 온찜질) > 통증 호전 안 될 시 수술, 근무 환경 자세 교정, 스트레칭 · 마사지

응급 상황 교육 – 배변 · 배뇨 이상, 감각 · 근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

부록

원본과 어긋난 지점 · 출처

지점	원본	이 가이드
문서 분리	목 통증과 허리 통증이 26번 한 항목	26-1 목과 26-2 허리로 분리했다. 감별 목록 · red flag · 신체진찰이 공유되지 않기 때문
허리 질환표의 무릎 질환	허리 통증 질환표 끝에 반달연골 파열과 내측 측부인대 손상 이 들어 있다	[확인 필요] 둘 다 무릎 질환이라 25장(관절 통증)의 표가 넘어온 편집 오류로 보인다. 이 가이드의 허리 질환 목록에서는 제외했고, 두 질환은 25번 가이드에서 다룬다
신체진찰 자세	P/E 항목표는 서서 > 침대에 앉아서 > 누워서 순이지만, keyword 상자는 (앉아서) 감각 · 근력 · DTR과 Schober, (엎드려서) 허리 ROM · 시진 · 촉진으로 적혀 있다	[확인 필요] P/E 항목표를 정본으로 삼았다. Schober는 서서 재는 검사이고, 시진 · 촉진과 ROM도 서서 하는 편이 자세 전환을 줄인다
연관통의 위치	증례별 알고리즘에는 연관통이 기타 원인의 한 갈래로 그려져 있다	대축 뒤가 아니라 관문 2 로 올렸다. 허리를 아무리 진찰해도 답이 안 나오고 그 사이 원인 질환이 진행하기 때문
C 염증 소견	문진표에 압통 · 발적 · 종창 · 열감 항목이 그대로 들어 있다	관절 CC에서 넘어온 항목으로 보아 DROP으로 내렸다. 다만 항목표에 있으므로 PART 12 대본 전문에는 남겼다
특이검사 술기	검사 이름과 양성 소견만 제시	PART 7의 손동작 · 판정 · 기전 · 흔한 실수는 표준 술기를 풀어 쓴 것으로 원본에 명시된 내용이 아니다. 실습에서 확인할 것
Quick Sheet 대조	-	한글 단일 소스로 제작했다. Quick Sheet에만 있는 항목이 있다면 반영되지 않았다

출처: 『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 26. 목 통증(Neck pain) / 허리 통증(Low back pain), p.271~282.